
MONOGRAFÍA DEL PRODUCTO

DEXTOS

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

DEXTOS, 27 mg/15 ml, jarabe.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

27 mg de bromhidrato de dextrometorfano por 15 ml de jarabe.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Jarabe.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1. Indicaciones terapéuticas

DEXTOS es utilizado en el tratamiento sintomático de la tos improductiva causada por irritación de las vías respiratorias altas o bajas.

4.2. Posología y forma de administración

En adultos y adolescentes (mayores de 12 años): 15 ml cada 6 ó 8 horas. Dosis máxima diaria recomendada de 60 ml.

Niños de 6 a 12 años: 7,5 ml cada 6 ó 8 horas. Dosis máxima diaria recomendada de 30 ml

Niños de 2 a 5 años: la posología será según indicación médica.

Niños *menores de 2 años*: no se recomendada su utilización.

No sobrepasar las dosis recomendadas o utilizar por periodos largos.

El jarabe puede tomarse diluido en agua o sin diluir.

4.3. Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los excipientes. Tos productiva. Tratamiento concomitante con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO).

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo

DEXTOS debe administrarse con precaución en pacientes asmáticos o atópicos, puesto que puede desarrollar liberación de histamina. Y también en pacientes sedados o debilitados.

En pacientes con enfermedad hepática ya que puede alterarse el metabolismo del dextrometorfano.

Si la tos persiste más de una semana, si reaparece o si va acompañada de fiebre alta, erupción en la piel o cefaleas intensas, un médico debe ser consultado.

DEXTOS contiene 121,64 g de sacarosa por cada 200 ml de jarabe. Una dosis de 15 ml contiene aproximadamente 9,123 g de sacarosa. No debe ser utilizado en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, síndrome de malabsorción de glucosa-galactosa o deficiencia de sacarasa-isomaltasa.

DEXTOS contiene 2,75 g de etanol al 96% por cada 200 ml de jarabe. Una dosis de 15 ml contiene aproximadamente 0,20 g de etanol al 96%. Puede ser perjudicial para los pacientes alcohólicos, pacientes con enfermedad hepática, epilepsia, enfermedad o traumatismo cerebral, y también para las mujeres embarazadas y niños. Puede alterar o aumentar el efecto de otros medicamentos.

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Inhibidores de la monoaminoxidasa - El uso simultáneo de dextrometorfano con inhibidores de la monoaminoxidasa (MAO) está contraindicado. Su uso concomitante ha provocado síndrome serotoninérgico, con síntomas que incluyeron náuseas, coma, hipertensión o hipotensión, temblores en las piernas, espasmos musculares e hiperpirexia, resultando en paro cardíaco o muerte. Debe respetarse un intervalo de 14 días entre la retirada de los inhibidores de la monoaminoxidasa y la ingesta de DEXTOS.

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRSs): La fluoxetina inhibe fuertemente la el sistema enzimático del citocromo P-450-2D6), la isoenzima que se sabe que cataliza el metabolismo del dextrometorfano en los humanos. Con la administración concomitante, es

posible que los dos agentes compitan entre sí y se inhiban mutuamente sus metabolismos, incrementando las concentraciones séricas de ambos fármacos. La coadministración de paroxetina con dextrometorfano ha intervenido en dos casos de síndrome serotoninérgico. Se sabe que la paroxetina inhibe la isoenzima CYP2D6 y es a su vez metabolizada por esta enzima. Con la administración concomitante, los dos agentes pueden competir e inhibirse mutuamente sus metabolismos. Sería de esperar por lo tanto que las concentraciones séricas de los dos medicamentos se incrementaran. No se dispone de datos sobre la administración concomitante de dextrometorfano y venlafaxina, pero es previsible un mecanismo similar de inhibición mutua del metabolismo, ya que la venlafaxina, además de ser un inhibidor de la CYP2D6, también es metabolizada por esta enzima.

Tioridazina: el uso de este antipsicótico debe evitarse con el dextrometorfano.

Antiarrítmicos: La quinidina es un inhibidor selectivo del citocromo P450 (CYP2D6). La coadministración con quinidina puede provocar concentraciones elevadas de dextrometorfano y un incremento de los efectos adversos. La amiodarona y la propafenona también parecen incrementar la concentración sérica de dextrometorfano.

Alcohol: El alcohol SNC debe evitarse con el dextrometorfano. La intoxicación por etanol es posible, ya que muchos productos de dextrometorfano utilizan etanol como vehículo. A pesar de que la concentración total de etanol consumida podría parecer marginal, existe el potencial de efectos adversos, incluyendo el desarrollo del síndrome de Wernicke-Korsakoff en pacientes con deficiencia de tiamina.

Haloperidol: El haloperidol es un inhibidor de la CYP2D6. La coadministración de dextrometorfano y haloperidol puede provocar concentraciones elevadas de dextrometorfano y un incremento de los efectos adversos.

Antibacterianos: Se han producido síntomas similares a los del síndrome serotoninérgico cuando se ha ingerido dextrometorfano junto con linezolid.

4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia

Aunque no existan datos evidentes relacionados con problemas fetales debido al dextrometorfano durante el embarazo o interferencia en el sistema reproductivo, DEXTOS no está recomendado durante el embarazo y la lactancia.

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas

DEXTOS no interfiere en la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

4.8. Reacciones adversas

Las reacciones adversas debidas a la utilización de DEXTOS son raras, pudiendo manifestarse, a veces, trastornos gastrointestinales, tales como náuseas y vómito, dolores de estómago, mareos y vértigo.

4.9. Sobredosis

La ingestión de grandes dosis de dextrometorfano provoca varios efectos psicotrópicos, principalmente como resultado de la acumulación del metabolito activo dextrofan. Quienes ingieren grandes dosis dicen experimentar inicialmente efectos estimulantes leves seguidos por alucinaciones y delirios. Posteriormente desarrollan sensaciones de disociación que con frecuencia describen como experiencias de "salida del cuerpo". Estos efectos están acompañados en muchos casos por sensaciones de euforia, ataxia, agitación y pérdida de concentración. Normalmente estos síntomas se producen cuando se ingieren dosis de dextrometorfano superiores a 2 mg/kg, mientras que las dosis más elevadas (>7 mg/kg) producen más efectos disociativos.

En los casos de ingestión aguda de grandes dosis, se ha informado de diversos efectos adversos, incluyendo nistagmo y midriasis. Puesto que se sabe que el dextrometorfano antagoniza los receptores de serotonina, el personal médico debe ser consciente de la posibilidad de que se produzca el síndrome serotoninérgico, que puede caracterizarse por diversos síntomas, incluyendo estado mental alterado, rigidez, hipertermia y calambres.

En los niños, el efecto clínico de una sobredosis es fundamentalmente de tipo neurológico, caracterizado por excitación central en lugar de sedación. Entre las manifestaciones observadas se incluyen alucinaciones, insomnio, histeria, náuseas y urticaria.

En caso de sobredosis se utilizarán medidas de tratamiento sintomático y de soporte y administración de naloxona intravenosa y administración oral de carbón activo.

La naloxona debe administrarse a las dosis estándar recomendadas para el tratamiento de las ingestiones de opioides (por ejemplo 0,4 - 2 mg I.V. cada 2 - 3 minutos hasta que se produzca una respuesta, con una dosis máxima de 10 mg

Puesto que DEXTOS® está formulado como bromhidrato de dextrometorfano, existe la posibilidad de toxicidad del bromuro asociada a la ingestión de cantidades significativas que resulta evidente a concentraciones séricas de bromuro mayores de 50 - 100 mg/dl. La toxicidad aguda puede provocar depresión del sistema nervioso central, hipotensión y taquicardia. La ingestión crónica puede provocar un síndrome de "bromismo", caracterizado por cambios de conducta, irritabilidad y letargia. No existe ningún antídoto específico para la toxicidad del bromuro. Las medidas terapéuticas consisten normalmente en la hidratación agresiva con suero fisiológico con el fin de promover la excreción urinaria y, en los casos graves, la hemodiálisis.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1. Propiedades farmacodinámicas

Código ATC: R05D A09.

El dextrometorfano es un antitusivo de acción central. Es un isómero del levorfanol, un análogo de la codeína. Al contrario de otros isómeros, el dextrometorfano es desprovisto de propiedades analgésicas, no causa dependencia y no actúa a través de los receptores opiáceos. Sus propiedades antitusivas resultan de su acción directa en el centro medular de la tos, aumentando su umbral de sensibilidad. Su potencia antitusígena es similar a la de la codeína, manteniéndose sus efectos durante 6 horas. Al revés de la codeína, su acción sedativa es prácticamente despreciable, observándose solamente con dosis extremadamente elevadas.

A dosis terapéuticas no inhibe la actividad ciliar de las vías respiratorias, lo que presenta una ventaja cuando comparado con otros fármacos antitusivos.

5.2. Propiedades farmacocinéticas

El dextrometorfano es rápidamente absorbido en el tracto gastrointestinal. El T_{max} es de 2 a 2,5 horas y la C_{max} tras una dosis oral de 60 mg es de 5,2 ng/ml. El efecto antitusígeno ocurre 15 a 30 minutos tras la administración oral y la duración de acción es de aproximadamente 5-6 horas.

El dextrometorfano se distribuye en el SNC, alcanzando concentraciones detectables en el líquido cefalorraquídeo (LCR). Estudios animales han demostrado que la relación concentración LCR/plasma varió entre 32,8 y 80%.

El fármaco sufre rápida y extensa metabolización hepática, originando un metabolito activo (dextrorfanol) y dos inactivos (3-metoximorfinano y morfinano-3-1). El dextrometorfano es metabolizado por la isoenzima CYP2D6, sufriendo desmetilación oxidativa.

El dextrometorfano y sus metabolitos desmetilados son excretados por vía urinaria. La semivida de eliminación del dextrometorfano es de 1,4 a 3,9 horas y del dextrorfanol es de 3,4 a 5,6 horas.

5.3. Datos preclínicos sobre seguridad

El dextrometorfano es un medicamento de uso corriente, y se halla descrito en prácticamente todas las farmacopeas.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1. Lista de excipientes

Sacarosa (9,123 g/15 ml), ácido cítrico anhidro, metilparabeno, esencia de naranja líquida, etanol al 96 por ciento y agua purificada.

6.2. Incompatibilidades

En ausencia de estudios de incompatibilidades este medicamento no debe mezclarse con otros.

6.3. Periodo de validez

5 años.

6.4. Precauciones especiales de conservación

Conservar en el embalaje original a temperatura inferior a 30°C.

6.5. Naturaleza y contenido del envase

Envase conteniendo un frasco de vidrio, tipo III, de color ámbar, y un prospecto. El frasco contiene 200 ml de jarabe. Incluye un vaso dosificador.

6.6. Precauciones especiales de eliminación

No procede.

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO

BIAL – Portela & C^a, S.A.
À Avenida da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

01139161115

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

Fecha de la Primera Autorización: 4 de Noviembre de 2015
Fecha de Renovación de la Autorización:

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO

29/08/2018